UE B3.2.1 · S1 · TD du 19 octobre 2026

Gestion du stress, souffrance au travail et analyse des émotions

Fiche de révision écrite • Patrice Marceau, psychologue clinicien et psychothérapeute corporel

POURQUOI CETTE FICHE ?

Comprendre la réaction de stress, reconnaître ses propres signaux, puis agir **avant, pendant et après** une situation éprouvante dans le contexte du soin.

Objectifs expressément présentés au début du TD

- Identifier les manifestations du stress et de l'anxiété.
- Repérer ses propres ressources face aux situations difficiles.
- Découvrir des stratégies simples de régulation émotionnelle.
- Développer une posture réflexive, en connaissant ses limites et ses réactions.

Priorités : ce qui est annoncé et ce qui est déduit

Explicite dans les objectifs du TD : identification des signes, ressources personnelles, régulation émotionnelle et réflexivité. En fin de séance, l'intervenant présente la synthèse pratique comme « le point essentiel ».

Déduit de la structure du support : définitions du stress, familles de risques psychosociaux, évaluation cognitive et coping, stress dépassé/chronique, épuisement professionnel, prévention et communication. Aucune liste particulière de questions d'examen n'est annoncée.

Réflexe de raisonnement pour les situations de soin

1 · Décrire	2 · Comprendre	3 · Agir
Repérer le stresseur et les signes observables.	Évaluer la menace ressentie et les ressources disponibles.	Choisir une action de régulation et du soutien adapté.
Distinguer faits, ressentis et interprétations.	Situer les conséquences possibles, sans diagnostiquer à partir d'un signe isolé.	Réévaluer après coup et adapter la prévention.

Sommaire cliquable

- Fondements et stresseurs
- Réactions biologiques et psychologie
- Stress dépassé, chronique et burn-out
- Identifier son propre stress
- Prévenir et réguler : agir dans les soins
- Pièges, synthèse et lexique

01 Définition : à quoi sert le stress ?

ESSENTIEL

Le stress est une **réaction d'adaptation**, à la fois physiologique et psychologique, face à une contrainte, une menace ou un changement. Il n'est pas en soi une maladie, mais la répétition et l'absence de récupération peuvent devenir délétères.

Hans Selye a décrit le **syndrome général d'adaptation** : l'organisme mobilise des moyens pour faire face à un agent agresseur. La réponse peut aider à agir, mais aussi déborder les capacités d'adaptation lorsqu'elle est excessive ou durable.

Notion	Comprendre	Exemple dans la vie soignante
Eustress	Stimulation vécue comme mobilisatrice ; elle peut favoriser l'action.	Une responsabilité nouvelle stimule l'apprentissage.
Distress / détresse	Situation vécue comme dépassant les ressources disponibles.	Un afflux de patients alors que l'équipe manque de moyens.
Stresseur	Événement, exigence ou condition qui déclenche la réaction.	Bruit, urgence, imprévu, conflit, douleur d'un patient.
Ressources	Moyens personnels et sociaux permettant de répondre.	Savoir-faire, récupération, collègue disponible, soutien.

Une balance plutôt qu'un phénomène identique pour tous

Stresseur → menace perçue → ressources et contrôle perçus → réactions → conséquences. Ce n'est pas seulement la gravité objective de l'événement qui détermine l'intensité vécue du stress : l'interprétation personnelle et la possibilité d'agir comptent.

NOTE DE COURS

Une situation positive (examen, réussite, mariage) peut également générer du stress : « positif » ne signifie pas « sans réaction physiologique ».

02 Les stresseurs professionnels et les RPS

Le TD distingue des **stresseurs ponctuels, fréquents ou omniprésents** ; leur répétition et la récupération insuffisante aggravent la charge globale.

Exemples de contraintes présentées dans le support

Matérielles et physiques	Psychosociales	Nature des interventions
Surcharge, interruption des tâches, bruit, manque de lumière, température inadaptée.	Pression institutionnelle, manque de reconnaissance ou de coopération, conflits, violences.	Mort, fin de vie, famille endeuillée, enfant malade, maladie psychiatrique.
Matériel absent ou inadapté, exposition biologique, absence de pauses et de récupération.	Course contre la montre, exigence de performance, agressivité verbale ou physique.	Responsabilité professionnelle, imprévu, mission sortant du cadre habituel.

Les six familles de facteurs de risques psychosociaux (RPS)

Famille (Gollac / INRS)	Ce que cela recouvre
1. Intensité et temps de travail	Charge, complexité, horaires, conflit entre vie personnelle et travail.
2. Exigences émotionnelles	Tensions avec le public, nécessité de cacher ses émotions.
3. Manque d'autonomie	Rigidité des procédures, compétences sous-utilisées.
4. Rapports sociaux dégradés	Conflits, absence de soutien ou de reconnaissance.
5. Conflits de valeurs	Devoir agir contre ses convictions, qualité des soins empêchée.
6. Insécurité de la situation	Incertitudes sur l'emploi, le métier ou son avenir.

À RETENIR

Les facteurs de stress au travail ne relèvent pas uniquement de la personne : **l'organisation, les conditions matérielles et les relations professionnelles** sont des déterminants majeurs.

La responsabilité et l'autonomie : stimulation ou anxiété

Le TD souligne une **double possibilité** : de nouvelles responsabilités peuvent être une source de développement et d'eustress, mais également provoquer de l'anxiété quand on débute, par peur de se tromper ou de ne pas être à la hauteur. Le repère utile n'est donc pas de fuir la responsabilité : il faut situer son niveau de compétence, les possibilités de demander conseil et les ressources effectivement accessibles.

APPLICATION EN STAGE

Un étudiant reçoit une mission nouvelle : il peut se sentir stimulé tout en craignant une erreur. Il explicite ce qu'il sait faire, ce qu'il doit faire vérifier et le soutien dont il a besoin auprès de son encadrant.

03 Les trois plans de la réaction de stress

Le cours articule trois plans complémentaires ; ils se manifestent ensemble, avec des intensités différentes selon les personnes et les situations.

Plan	Réactions possibles	Ce que le soignant peut observer
Biologique / physique	Mise en alerte, activation cardio-respiratoire, tension musculaire, mobilisation énergétique.	Respiration accélérée, crispation, agitation physique, sensation de fatigue.
Psychologique	Évaluation cognitive, peur, colère, inquiétude, sentiment d'insécurité.	Pensées focalisées sur le danger, difficulté à prendre du recul.
Comportemental	Inhibition / figement, explosion / agitation, évitement / fuite.	Silence inhabituel, gestes précipités, retrait, difficulté à s'affirmer.

Réaction archaïque : faire face à une menace

Le cerveau favorise une réaction rapide de défense souvent formulée « **combattre ou fuir** ». Utile face à un danger immédiat, cette mobilisation peut devenir inadaptée quand le stresseur est permanent ou surtout relationnel.

POUR COMPRENDRE

Une réaction physique forte ne prouve pas à elle seule un danger grave ; elle signale la mise en alerte de l'organisme. Les émotions et les comportements sont aussi influencés par la signification donnée à la situation.

04 Les voies biologiques et les phases du stress

Deux voies présentées dans le TD

Voie rapide : système nerveux autonome	Voie hormonale : axe de stress
Activation sympathique et médullosurrénale, libération d'**adrénaline** et de **noradrénaline** (catécholamines).	Activation de l'axe hypothalamus–hypophyse–corticosurrénale ; **ACTH** hypophysaire puis sécrétion de **cortisol**.
Prépare immédiatement à agir : vigilance, fréquence cardiaque, ventilation et mobilisation musculaire.	Contribue à la mobilisation et au maintien de la réponse lorsque la sollicitation se prolonge.

Les effets décrits dans les diapositives comprennent une plus forte vigilance, un apport énergétique disponible (glucose, oxygène), une mobilisation cardio-respiratoire et une mise en tension motrice. La digestion devient moins prioritaire dans cette situation d'alerte.

Syndrome général d'adaptation : modèle en trois phases

Phase	Idée centrale	Conséquence à comprendre
1. Alarme	Mobilisation rapide devant l'agent stressant.	L'organisme déclenche une réponse d'alerte et de défense.
2. Résistance	Maintien de l'adaptation lorsque la contrainte persiste.	Le corps et l'attention restent sollicités ; récupération nécessaire.
3. Épuisement	Les ressources ne suffisent plus à soutenir l'adaptation.	Augmentation des difficultés, baisse des capacités de réponse.

À RETENIR

Alarme – résistance – épuisement sont les trois phases du modèle enseigné. Elles aident à raisonner sur la durée du stress, sans permettre à elles seules de poser un diagnostic.

05 Évaluation cognitive : Lazarus et Folkman

Dans le **modèle transactionnel**, la réponse psychologique n'est pas automatique : elle dépend de l'évaluation de la situation et des ressources. Deux évaluations sont distinguées dans le support.

Évaluation primaire : stress / menace perçus	Évaluation secondaire : contrôle / ressources perçus
« Est-ce menaçant pour moi ? Est-ce que cela met mon bien-être en jeu ? »	« Que puis-je faire ? Quelles capacités, compétences, soutiens et marges de manœuvre ai-je ? »

Le coping : chercher une manière d'ajuster la situation

Le **coping** désigne les stratégies d'ajustement utilisées pour faire face à une situation évaluée comme difficile. Le TD le relie à la mobilisation de ressources, à la compréhension, à l'action et à l'autorégulation. Le support annonce des « styles de coping » sans en dresser une classification détaillée ; il ne faut donc pas attribuer au cours une typologie non développée.

Contrôle perçu : trois questions utiles

Comprendre	Agir	Se réguler
Que se passe-t-il réellement et quelle est la part de mon interprétation ?	Quelles marges d'action, quelles compétences, quel soutien humain puis-je mobiliser ?	Que puis-je faire pour que la peur ou la colère ne dirigent pas seules ma réaction ?

Ces trois dimensions sont explicitées oralement. **Le contrôle perçu n'implique pas un contrôle total** de la situation : demander un appui ou reconnaître ses limites est déjà une manière d'ajuster sa réponse.

EXEMPLE INSPIRÉ DU TD

Un patient critique un soin. La réaction immédiate peut être : « J'ai mal fait ». Replacer les propos dans le contexte (douleur, difficulté relationnelle, situation clinique) aide à distinguer le ressenti du fait et à rechercher une réponse ajustée, sans écarter toute possibilité d'erreur.

06 Réactions cognitives, émotionnelles et comportementales

Sur le plan cognitif : attention au « tunnel »

En situation de stress intense, l'observation peut se **rétrécir** (« effet tunnel ») : on se focalise sur un élément et l'on risque de négliger le reste. Une excitation émotionnelle forte peut déstabiliser et faire perdre ses moyens, notamment en début de carrière.

Sur le plan émotionnel : l'état des besoins compte

Le TD lie les émotions à l'état de satisfaction des besoins fondamentaux. Joie, calme ou sérénité peuvent accompagner des besoins satisfaits ; colère, peur, tristesse et irritabilité peuvent signaler un besoin contrarié. Une émotion informe, mais **n'établit pas à elle seule la réalité objective** d'une situation.

Réaction spontanée	Manifestation	Alternative travaillée dans le TD
Inhibition	Se figer, ne plus répondre ou ne rien exprimer.	Identifier son besoin et demander de l'aide, formuler sa position.
Explosion	Parler ou agir brusquement, s'agiter.	Réduire l'activation puis exprimer clairement le ressenti.
Évitement / fuite	S'éloigner de la difficulté ou la repousser.	Évaluer s'il faut se protéger, puis préparer une réponse adaptée.
Affirmation de soi	Exprimer un point de vue sans domination ni soumission.	Choisir le bon moment, respecter l'autre et ses propres limites.

À RETENIR

S'affirmer n'est pas agresser. La souplesse comportementale consiste à **choisir sa réponse** plutôt qu'à répéter automatiquement une inhibition, une explosion ou une fuite.

07 Le cycle émotionnel : charge, expression, repos

Le support propose une lecture en quatre temps du cycle émotionnel ; cette présentation constitue un **outil pédagogique du TD** pour comprendre la régulation et non un test diagnostique.

Temps	Description du support	Exemple d'application
1. Charge	Excitation sensitive, activation sympathique, montée du stress.	Prendre conscience de la tension et de la respiration.
2. Décharge expressive	Expression volontaire ou involontaire : action, parole, émotion.	Parler du vécu, bouger, relâcher certaines tensions.
3. Décharge végétative / repos	Place donnée à la récupération et au parasympathique.	Se poser, respirer calmement, prendre une pause réelle.
4. Retour à l'équilibre	Reprise d'un état de bien-être relatif.	Réévaluer son niveau physique et psychique.

NOTE DE COURS

Le TD insiste sur la nécessité de ne pas tout « emporter » après le travail : repérer ce qui est encore chargé émotionnellement et s'accorder un espace d'expression ou de récupération.

08 Les formes de stress à distinguer

Type présenté	Définition ou manifestations décrites
Stress général	Réaction adaptative à une contrainte ou à un événement.
Stress dépassé	Les capacités habituelles sont momentanément débordées, la personne ne parvient plus à faire face.
Stress différé	Réaction survenant après coup, parfois au moment du relâchement.
Stress chronique	Sollicitation répétitive ou persistante sans récupération suffisante, pouvant favoriser l'épuisement.

Stress dépassé : les quatre réactions « SAFA »

S : sidération	A : agitation incoordonnée	F : fuite panique	A : actions automatiques
Paralysie de l'action et de la volonté.	Excitation et gesticulation désorganisées, décision difficile.	Fuite sans raisonnement adapté.	Gestes répétitifs et machinaux malgré une apparence parfois normale.

EXEMPLE DE RAISONNEMENT

Face à un collègue figé après un événement brutal, ne pas confondre absence de mouvement et absence de détresse. Le cours présente la **sidération** comme une forme possible de stress dépassé.

09 Stress chronique : manifestations et retentissement

Le stress chronique peut altérer les fonctions professionnelles, la santé physique, l'humeur et les comportements. Le cours invite à repérer les **changements par rapport au fonctionnement habituel**.

Domaine	Signaux cités dans le TD
Travail et vigilance	Difficultés de concentration, perte d'efficacité, oublis, erreurs, absentéisme et perte d'élan.
Physique	Fatigue durable, troubles du sommeil, douleurs, tensions posturales et troubles musculosquelettiques.
Psychique	Anxiété, irritabilité, démotivation, dévalorisation, pessimisme, humeur dépressive.
Comportemental	Agressivité ou retrait, sollicitations d'aide inhabituelles, changements de consommation (alcool, tabac, médicaments), alimentation modifiée.
Santé globale	Le support évoque les risques cardiovasculaires, digestifs et d'autres atteintes possibles liés à la persistance du stress.

À RETENIR

Un signe isolé ne suffit pas à conclure à un épuisement professionnel. L'association de manifestations, leur persistance et leur retentissement doivent conduire à rechercher du soutien et une évaluation appropriée.

Comment repérer un changement préoccupant dans le travail ?

Le support cite une **baisse de concentration, les oublis et les erreurs**, puis l'absentéisme ou la perte d'élan. Physiquement, il évoque notamment des troubles musculosquelettiques, des troubles du sommeil et des plaintes digestives ; psychiquement, une irritabilité ou une dévalorisation nouvelles. Ces signes sont **non spécifiques** : on examine leur accumulation et leur évolution sans conclure à un diagnostic. En stage, alerter son encadrant d'une difficulté de vigilance ou d'une fatigue qui compromet la sécurité relève d'une démarche prudente, non d'un jugement sur soi.

10 Burn-out : comprendre les trois dimensions

Le **burn-out** est présenté comme un épuisement professionnel associé à des contraintes répétées et rapprochées, un manque de récupération, de soutien ou des responsabilités particulièrement exigeantes. Le surinvestissement peut masquer l'épuisement.

Dimension du modèle utilisé dans le TD	Comment elle peut apparaître
1. Épuisement émotionnel	Fatigue physique, mentale et affective face aux exigences du travail ; repos habituel devenu insuffisant.
2. Dépersonnalisation / cynisme	Distance émotionnelle, froideur, paroles négatives ; mise à distance des patients et collègues comme protection.
3. Diminution de l'accomplissement personnel	Sentiment d'inefficacité, dévalorisation, perte de sens et impression de ne plus être à la hauteur.

Risques et facteurs abordés oralement

• Sur-engagement, impossibilité de dire non, dépendance au regard d'autrui, peur de décevoir.

• Manque d'appui du collectif, horaires ou charge excessifs, isolement, confrontation répétée à la souffrance et à la mort.

• Désir de tout réaliser soi-même, autocritique excessive, « mentalité de sauveur », anxiété et manque de repos.

EXEMPLE EXPLICATIF DU TD

L'intervenant raconte un professionnel qui continue à se surinvestir malgré une fatigue importante, jusqu'à ne plus pouvoir travailler. L'objectif de cet exemple est de montrer que **tenir à tout prix** peut retarder la reconnaissance de l'épuisement et allonger la récupération.

Retentissement sur le soin

La relation avec le patient peut se détériorer : diminution de l'attention, propos cyniques, retrait, erreurs, accidents et parfois comportements maltraitants. **Repérer tôt les signes d'alerte protège aussi la qualité des soins.**

À RETENIR

Les trois dimensions sont des **repères descriptifs** issus du modèle étudié : elles ne doivent pas être présentées comme trois étapes chronologiques obligatoires chez toute personne.

11 Psychotraumatisme : un volet volontairement bref

Les diapositives évoquent un événement potentiellement traumatisant : confrontation à la mort ou à une violence intense, imprévisibilité, effroi, sentiment d'impuissance. Elles présentent des réactions possibles immédiates et différées.

Réactions décrites	Exemples du support
Répétition / reviviscence	Souvenirs intrusifs, impressions de revivre la scène, cauchemars.
Évitement	Évitement des situations, pensées et émotions rappelant l'événement.
Hyperréactivité et humeur	Sursaut, troubles du sommeil, irritabilité, retrait social, baisse d'intérêt.
Signes associés	Fatigue, anxiété, plaintes somatiques, modifications comportementales.

NOTE DE COURS

L'intervenant précise qu'il **survole volontairement ce chapitre**, traité plus tard en psychopathologie. Ne pas faire du simple stress différé un diagnostic de trouble de stress post-traumatique.

12 Identifier son stress : apprendre à se lire

Le TD commence par une **auto-évaluation simultanée** du physique et du psychique : deux notes entre **0 et 5**, de l'état très dégradé à la grande forme. Cette échelle sert au repérage personnel en séance : ce n'est pas une échelle diagnostique standardisée présentée comme telle.

Repère à observer	Questions utiles
État physique	Est-ce que je dors et récupère ? Suis-je tendu, épuisé ou au contraire disponible ?
État psychique	Suis-je serein, irritable, anxieux, débordé, démotivé ?
Réactivité	Ai-je tendance à me figer, m'agiter, réagir trop vite ou avoir du mal à me mobiliser ?
Sensibilité et activité mentale	Quelle place prennent mes émotions, ma sensibilité et la rumination ?
Regard extérieur	Les personnes de confiance ont-elles constaté un changement ?

Entre hyporéactivité et hyperréactivité

Le TD propose trois axes de connaissance de soi : **tonus/réactivité** (difficulté à se mobiliser versus tension permanente), **sensibilité émotionnelle** (très sensible versus peu réceptif) et **activité mentale** (hyperactivité versus ralentissement). Il ne s'agit pas d'étiqueter un tempérament comme bon ou mauvais, mais de repérer ses réactions habituelles puis les **changements sous pression**.

EXEMPLE DE RETOUR RÉFLEXIF

Après une situation difficile, je note séparément mon état physique et psychique sur 0–5. Si je reste très tendu, je cherche une récupération ; si je reste « éteint », je m'interroge sur le repos et le soutien nécessaires. Les notes décrivent un ressenti personnel, elles ne donnent aucun diagnostic.

Quand on produit soi-même une partie de sa pression

Le support parle de **stress auto-créé** : exigences personnelles excessives, idéal professionnel irréaliste, manque de confiance et interprétation des réactions d'autrui. Le TD encourage à ne pas transformer une hypothèse (« ma collègue m'en veut ») en certitude sans vérifier.

EXEMPLE DE COURS

Une cadre ne dit pas bonjour : en déduire immédiatement « elle me reproche une erreur » peut alimenter l'anxiété. Une explication alternative peut exister. Il vaut mieux rechercher des faits, questionner et prendre du recul.

13 Besoins, émotions et estime de soi

Le support utilise une pyramide des besoins fondamentaux : besoins **physiologiques**, **sécurité**, **appartenance**, **estime**, puis **accomplissement**. Elle sert ici à questionner l'équilibre personnel, pas à imposer un ordre rigide valable en toute situation.

Besoin	À explorer en situation de stress
Physiologique	Sommeil, alimentation, hydratation, respiration, récupération.
Sécurité	Prévisibilité, cadre professionnel, ressources pour se protéger.
Appartenance	Soutien, équipe, relation de confiance, possibilité de parler.
Estime	Reconnaissance, confiance, auto-valorisation, autonomie.

Besoin	À explorer en situation de stress
Accomplissement	Sens du travail et sentiment de progresser dans ses compétences.

L'enseignant insiste sur **l'estime de soi** : elle soutient la capacité à poser ses limites, à ne pas dépendre totalement du regard d'autrui et à prendre une décision professionnelle ajustée.

> **À RETENIR**
> Être très investi et compétent ne dispense pas de récupérer, de recevoir de l'aide et de respecter ses besoins. La préservation de soi et la qualité de la relation soignante ne s'opposent pas.

En conclusion, le support invite à **réévaluer ses besoins fondamentaux au moins une fois par mois**. C'est un repère de réflexion personnel proposé dans ce TD, non un délai clinique universel. Pour chaque besoin, se demander : « Est-il suffisamment respecté ? Que puis-je changer ou demander ? »

14 Prévenir et réguler : trois temps de gestion

Le TD distingue trois moments de l'action, qu'il appelle gestion **primaire, secondaire et tertiaire**. Ce sont des repères temporels internes à ce cours : **avant, pendant, après** la situation de stress.

Moment selon le TD	Objectif	Pistes abordées
Primaire · avant	Réduire l'exposition et renforcer les ressources.	Pause, préparation, organisation, récupération, soutien, connaissance de ses limites.
Secondaire · pendant	Limiter la montée émotionnelle et préserver l'action ajustée.	Respirer, se recentrer, demander de l'aide, s'affirmer sans agressivité.
Tertiaire · après	Faciliter le retour à l'équilibre et apprendre de l'expérience.	Parole, décharge corporelle, repos, bilan, ajustements futurs.

> **EXEMPLE EN STAGE**
> **Avant :** clarifier qui appeler si un geste est difficile. **Pendant :** prendre quelques respirations, exposer la difficulté au tuteur. **Après :** débriefer et identifier ce qui facilitera la prochaine situation.

Attention aux seuls outils individuels

Les exercices de relaxation peuvent aider à réguler un vécu, mais ils ne remplacent pas l'action sur les **conditions de travail, la charge, les équipements, l'organisation et le soutien collectif** lorsque ces facteurs génèrent le stress.

15 Techniques simples travaillées en séance

Respiration et cohérence cardiaque

Le TD propose un exercice de **cohérence cardiaque** et évoque une action sur la régulation parasympathique et le nerf vague. Le support ne fixe pas de protocole chiffré obligatoire ; la fiche n'en ajoute donc pas.

Ancrage, détente et espace corporel

- **Ancrage :** sentir les appuis corporels, l'environnement présent et ralentir la réaction automatique.
- **Respiration consciente :** observer le souffle et chercher un rythme confortable, sans forcer.
- **Détente et récupération :** relâcher les tensions, se ménager des pauses, de la lumière et du mouvement adapté.

• **Expression :** pouvoir parler du vécu, écrire, mettre en mots un ressenti ou pratiquer une activité corporelle appréciée.

> **NOTE DE COURS**
>
> La finalité des exercices est d'éprouver **corporellement** ce qui a été expliqué intellectuellement. L'intervenant souligne que le TD de trois heures condense habituellement un enseignement plus long.

Prendre soin de son équilibre au quotidien

Le support propose de bouger, mieux dormir, préserver les repas, pratiquer des loisirs, s'exposer à la lumière du jour et aller dans la nature. Les modalités sont à personnaliser. Les exemples d'approches citées dans les diapositives ne constituent pas toutes des traitements validés ni des obligations de soin.

Parmi les **approches citées à titre d'exemples**, le support distingue des activités corporelles (sport-plaisir, relaxation, automassage, sophrologie, tai-chi), psychiques (yoga, méditation) ou de détente générale. Il évoque également des pratiques telles que l'ostéopathie ou les huiles essentielles : cette énumération décrit les **propositions de la séance** et ne vaut ni recommandation médicale universelle ni preuve d'efficacité équivalente.

Les sas de transition : ne pas attendre de « craquer »

Le support écrit suggère un **sas de transition d'au moins 20 minutes** lorsque l'on n'en peut plus. À l'oral, l'intervenant précise qu'**une ou deux minutes** peuvent aussi servir de micro-pause entre deux patients : sortir de la chambre, respirer, s'étirer et repartir plus posé. Ce ne sont pas deux durées contradictoires d'un protocole : l'une décrit un temps de récupération plus ample, l'autre de brefs retours au calme répétés selon les contraintes du service.

> **APPLICATION EN STAGE**
>
> Après un soin émotionnellement chargé, si la situation le permet, prendre un court temps pour relâcher sa tension et signaler à l'équipe un besoin de relais. En fin de journée, ménager un vrai temps de transition et échanger avec une personne ressource si nécessaire.

16 S'affirmer, débriefer et ajuster sa posture

Les trois champs de réaction proposés en conclusion sont **physique – réguler**, **psychique – transformer** et **comportemental – ajuster**. Ils permettent de choisir une action en accord avec son état du moment.

Physique : réguler	Psychique : transformer	Comportemental : ajuster
Repérer les sensations, agir sur les appuis, le souffle et la récupération.	Mettre des mots sur l'émotion, recontextualiser la situation et discuter des interprétations.	Exprimer son ressenti et ses besoins, demander un soutien, refuser une demande inadaptée.

Expression de ses besoins et communication non violente

La synthèse du TD recommande de communiquer sans plainte ni reproche : décrire ce que l'on vit, exprimer un besoin, chercher une solution, reconnaître ses limites et tolérer celles d'autrui. **Dire non** peut être une compétence de protection de soi et des soins lorsqu'une demande excède les moyens ou le cadre professionnel.

> **EXEMPLE DE FORMULATION**
>
> « Je suis en difficulté pour réaliser cette tâche en sécurité dans le temps imparti. J'ai besoin d'un soutien ou de revoir les priorités avec toi. » Cette formulation expose une situation et un besoin plutôt que de blâmer un collègue.

Mini-grille de retour réflexif après une situation

- **Faits :** que s'est-il passé, concrètement ?
- **Réactions :** qu'ai-je ressenti dans mon corps, mes pensées et mes gestes ?
- **Ressources :** qu'est-ce qui m'a aidé ou manqué ?
- **Ajustement :** qu'est-ce que je pourrai préparer, demander ou modifier ?

> **À RETENIR**
>
> La posture réflexive n'est pas la culpabilisation : c'est la capacité à **observer, comprendre, ajuster et apprendre**, tout en recherchant l'appui collectif lorsque c'est nécessaire.

Le rôle du futur IDE : une réponse proportionnée à la situation

Observer / évaluer	Agir dans son cadre	Réévaluer / transmettre
Repérer les signes physiques, émotionnels et comportementaux, la gêne pour agir, le contexte de travail et les ressources disponibles.	Sécuriser la situation de soin, solliciter le tuteur ou l'équipe, exprimer un besoin concret, prévoir une pause/récupération lorsque possible.	Vérifier si la tension baisse, ce qui reste difficile et si un relais ou un échange professionnel est utile ; décrire les faits sans étiqueter un collègue.

Ce raisonnement est une **application pédagogique aux situations de stage** des objectifs du TD ; le support ne donne pas de protocole infirmier de dépistage ou de diagnostic du burn-out.

17 Pièges QCM / confusions à éviter

Confusion fréquente	Correction utile
« Le stress est toujours pathologique. »	Non : une réponse brève au stresseur peut être adaptative.
« Un événement heureux ne peut pas stresser. »	Il peut mobiliser fortement l'organisme malgré son caractère positif.
« Le stress dépend uniquement du stresseur. »	La menace perçue, les ressources et le contrôle perçu comptent.
« Risques psychosociaux = fragilité individuelle. »	Les six familles concernent aussi l'organisation, les relations et les valeurs.
« Évaluation primaire = recherche de solutions. »	Primaire : menace ; secondaire : ressources et contrôle.
« Adrénaline et cortisol désignent la même voie. »	Voie sympathique / catécholamines et axe hormonal / cortisol sont distingués.
« Stress dépassé = stress chronique. »	L'un désigne un débordement actuel ; l'autre une répétition ou durée.
« SAFA est une échelle de diagnostic. »	Dans ce TD, c'est une aide-mémoire des réactions au stress dépassé.
« Toute fatigue signifie burn-out. »	Non : repérer l'évolution, le contexte, les dimensions et le retentissement.
« Les trois dimensions du burn-out sont trois étapes obligatoires. »	Le TD présente trois dimensions descriptives ; la chronologie n'est pas systématique.

Confusions à éviter — suite

Confusion fréquente	Correction utile
« Stress différé = trouble de stress post-traumatique. »	Le stress différé ne suffit pas à caractériser ce trouble.
« Une personne figée ne ressent rien. »	La sidération peut être une réaction de stress dépassé.
« S'affirmer = s'opposer agressivement. »	L'affirmation choisit une expression adaptée et respecte les limites.
« Gérer le stress = seulement respirer. »	La prévention inclut aussi les facteurs professionnels et l'accès au soutien.
« Gestion tertiaire = agir avant le stress. »	Dans la terminologie du TD, tertiaire = après ; primaire = avant.
« Ressentir la colère prouve que le collègue est hostile. »	L'émotion est réelle, l'interprétation doit être vérifiée.
« Une pause doit toujours durer exactement 20 minutes. »	Le support propose un sas prolongé ; l'oral évoque aussi de brèves micro-pauses entre patients selon la situation.
« Être autonome signifie ne jamais demander d'aide. »	L'autonomie peut s'exercer en reconnaissant ses compétences, ses limites et les relais nécessaires.
« L'auto-évaluation 0–5 diagnostique l'épuisement. »	Il s'agit d'un repère personnel subjectif, sans valeur diagnostique dans ce TD.
« Se reposer uniquement après les gros événements suffit. »	Le cours insiste sur la récupération répétée et la relecture régulière de ses besoins.

18 Synthèse générale — L'essentiel du cours

Ce que tu dois savoir expliquer rapidement

• Le stress est une réaction d'adaptation ; il résulte de la confrontation entre des contraintes et des ressources perçues.

• Les stresseurs professionnels comprennent des facteurs matériels, relationnels et organisationnels, répartis en six familles de RPS.

• La réaction comporte des dimensions biologique, cognitive/émotionnelle et comportementale.

• Système sympathique et catécholamines participent à l'alerte immédiate ; l'axe hormonal contribue à la réponse de stress.

• Le modèle de Selye distingue alarme, résistance et épuisement ; Lazarus et Folkman distinguent menace et contrôle/ressources perçus.

• Le stress dépassé peut se traduire par SAFA ; le stress chronique entraîne des modifications durables à repérer.

• Le burn-out est décrit par épuisement émotionnel, cynisme/dépersonnalisation et moindre accomplissement personnel.

• La régulation se prépare avant le stress, s'effectue pendant et se poursuit après : respiration, ancrage, récupération, parole, affirmation de soi, soutien de l'équipe.

• L'objectif final est une posture souple, lucide et réflexive : connaître ses limites, respecter ses besoins et rechercher des solutions.

> **RÉFLEXE PRATIQUE À EMPORTER EN STAGE**
>
> « **Je repère** ce qui se passe dans mon corps, mes pensées et mes actions ; **je distingue** la situation de son interprétation ; **je mobilise** des ressources ; **je demande** de l'aide si nécessaire ; **j'analyse** après coup. »

Pour appliquer cette synthèse en stage : distinguer des **micro-pauses** entre deux patients et un **sas de transition plus long** en fin de journée ; se rappeler que l'autonomie peut stimuler et inquiéter ; revenir sur son état physique, psychique et ses besoins dans la durée.

19 Définitions et mots-clés

Lexique sélectionnable — repères de mémorisation et réutilisation orale

Stress	Réaction physiologique et psychologique d'adaptation à une contrainte ou une menace.
Stresseur	Agent, événement ou condition pouvant déclencher une réaction de stress.
Eustress	Stress vécu comme mobilisateur ou stimulant dans le TD.
Distress	Détresse liée à un stress éprouvé comme excessif ou dépassant les ressources.
Syndrome général d'adaptation	Modèle de Selye décrivant alarme, résistance et épuisement.
Phase d'alarme	Mobilisation rapide de l'organisme devant un stresseur.
Phase de résistance	Maintien de l'effort d'adaptation sous contrainte persistante.
Phase d'épuisement	Insuffisance des capacités d'adaptation dans le modèle étudié.
Risques psychosociaux (RPS)	Facteurs professionnels pouvant atteindre la santé physique et psychique.
Exigences émotionnelles	Sollicitations affectives du travail, notamment nécessité de gérer ou masquer ses émotions.
Conflit de valeurs	Décalage entre les exigences de travail et les convictions professionnelles.
Qualité empêchée	Impossibilité ressentie de faire son travail conformément à ses critères de qualité.
Système nerveux autonome (SNA)	Système impliqué dans la régulation de fonctions corporelles automatiques.
Sympathique	Branche du SNA associée à la mobilisation en situation d'alerte.
Parasympathique	Branche du SNA associée notamment à la récupération et au repos dans le TD.
Catécholamines	Famille comprenant adrénaline et noradrénaline, mobilisée dans la réaction de stress.
ACTH	Hormone hypophysaire participant à la stimulation du cortex surrénalien.
Cortisol	Glucocorticoïde sécrété par le cortex surrénalien dans la réponse au stress.
Évaluation primaire	Appréciation de la menace ou du stress perçu.
Évaluation secondaire	Appréciation des ressources et du contrôle perçus pour faire face.
Contrôle perçu	Sentiment de pouvoir comprendre, agir sur la situation ou se réguler.
Coping	Stratégies d'ajustement utilisées pour faire face à une situation stressante.
Effet tunnel	Restriction de l'attention ou de l'observation sous stress.
Inhibition	Réponse de retrait ou de figement face au stress.
Explosion	Réponse comportementale d'agitation ou d'expression brusque.

Définitions et mots-clés — suite

Évitement	Réponse consistant à se soustraire à une situation ou à son rappel.
Affirmation de soi	Expression adaptée de sa position et de ses limites sans agressivité.
Stress dépassé	Situation où les capacités habituelles d'adaptation sont momentanément débordées.
SAFA	Sidération, agitation incoordonnée, fuite panique, actions automatiques.
Stress différé	Réaction de stress ou de relâchement survenant après l'événement.
Stress chronique	Réaction liée à des stresseurs répétés ou persistants avec récupération insuffisante.
Burn-out	Épuisement professionnel abordé à travers trois dimensions dans le TD.
Épuisement émotionnel	Fatigue et sentiment de ne plus pouvoir répondre aux exigences affectives du travail.
Dépersonnalisation / cynisme	Détachement négatif ou mise à distance des personnes liées au travail.
Diminution de l'accomplissement personnel	Sentiment d'inefficacité et de perte de sens au travail.
Psychotraumatisme	Conséquences psychiques possibles d'un événement potentiellement traumatisant.
Reviviscence	Impression de revivre un événement par souvenirs intrusifs ou cauchemars.
Hyperréactivité	État de vigilance ou réactivité excessive, évoqué parmi les signes post-traumatiques.
Cycle émotionnel	Schéma pédagogique : charge, expression, repos et retour à l'équilibre.
Ancrage	Exercice de centrage sur les sensations corporelles et le moment présent.
Cohérence cardiaque	Exercice respiratoire présenté pour agir sur la régulation du stress.
Gestion primaire / secondaire / tertiaire	Dans ce TD : agir respectivement avant, pendant et après le stress.
Posture réflexive	Capacité à analyser ses réactions, ses ressources et ses ajustements professionnels.
Estime de soi	Évaluation personnelle de sa propre valeur, mobilisée dans l'affirmation et la régulation.
Congruence	Cohérence entre son vécu, ce que l'on exprime et sa posture relationnelle.
Empathie	Capacité à chercher à comprendre le vécu d'autrui tout en gardant sa place.
Communication non violente	Approche d'expression des ressentis et besoins en limitant reproche et agressivité.
Sas de transition	Temps volontaire de respiration, de relâchement ou de récupération entre des sollicitations ; court ou plus ample selon le contexte.
Auto-évaluation physique / psychique	Notation subjective distincte de ces deux états, sur 0 à 5 dans ce TD ; repère personnel non diagnostique.
Hyperréactivité / hyporéactivité	Repères d'un continuum de réactions : tension ou mobilisation excessive versus difficulté à se mobiliser.